

ПЭТ-КТ исследование с контрастным усилением ФДГ
Второе медицинское мнение

Дата расшифровки: 25/03/2024

Имя пациента: Жерлицына Анастасия

Дата рождения: 25/04/1976

Причина направления: наблюдение и лечение метастатического заболевания типа ГИСО.

Дата исследования: 14/03/2024

Методика: исследование выполнено после внутривенной инъекции контраста, без перорального приема контрастного вещества.

Сравнение с предыдущими исследованиями: 17/08/2023

Описание наблюдений:

Голова и шея:

Как известно, оценка паренхимы головного мозга в рамках этого исследования ограничена.

Насколько можно судить, без видимых патологий.

Без признаков гиперметаболической лимфаденопатии в области шеи.

Щитовидная железа: размеры в пределах нормы, без патологического накопления контраста.

Грудная клетка:

Определяются уже известные небольшие узелки в легких с обеих сторон – без изменений, находятся за пределами разрешающей способности ПЭТ.

Без плевральных выпотов.

Определяется минимальный перикардальный выпот – без изменений.

Без патологического накопления контраста в лимфоузлах средостения и ворот легких.

Без патологического накопления контраста в паренхиме молочных желез.

Без патологического накопления контраста в подмышечных лимфоузлах.

В правой подмышечной впадине наблюдается венозный катетер Port-A-Cath, его край в ВПВ.

Брюшная полость и малый таз:

Печень: определяются уже известные гиподенсные образования в обеих долях печени – без существенных изменений, без патологического накопления контраста. Например, лишь несильное периферическое накопление контраста определяется в основании крупного образования (15 см в боковой проекции). Размеры образования с лобулярными краями в левой доле сократились с 5,8 до 4,8 см.

Желчный пузырь: не увеличен. Внутривенные желчные протоки расширены.

Портальная вена проходима.

Размеры известного образования стенки желудка несколько сократились, на высоте, где раньше было 4,5 x 3,2 см, на этот раз – 4,0 x 2,8 см. Лишь незначительное накопление контраста.

Селезенка: размеры в пределах нормы, без патологического накопления контраста.

Патологического накопления контраста в паренхиме поджелудочной железы не отмечалось.

Правый надпочечник: оттеснен печенью, без образований, без патологического накопления контраста.

Левый надпочечник: утолщен, без патологического накопления контраста, без изменений.

Почки: без гидронефроза или обызвествленных камней.

Без признаков гиперметаболической лимфаденопатии брюшной полости, забрюшинного пространства или малого таза.

Без патологического накопления контраста в паховых лимфоузлах.

Мочевой пузырь: без патологий.

Кишечные петли: без патологий, насколько можно судить.

Матка: размеры известных неоднородных образований сократились. Образование, расположенное более краниально, сократилось с 9,5 до 6,5 см в боковой проекции. Образование, расположенное более каудально, сократилось в меньшей степени – с 5 x 5,5 см до 4,8 x 5,1 см.

Размеры дополнительного образования в области малого таза справа сократились с 5,1 x 6 см до 5,3 x 4,8 см. Оно гиподенсно относительно других образований, имеет четкую границу.

Костная ткань:

Без очагового накопления контраста или деструктивных процессов в области сканирования.

Заключение:

Образование, прилежащее к стенке желудка, и образования печени – без существенных изменений (некоторые из них лишь слегка сократились в размерах), не являются гиперметаболическими.

Выявлено сокращение размеров известных маточных образований, как описано выше.

Состояние легочных узелков стабильное.

С уважением,
Д-р Куликов Виктория
Специалист по ядерной медицине
№ лицензии: 84847
№ лицензии специалиста: 131252